

Síndrome de Intestino Irritable (SII)

1. Introducción y relevancia clínica

El **síndrome de intestino irritable (SII)** es un **trastorno funcional gastrointestinal crónico**, caracterizado por **dolor o malestar abdominal asociado a alteraciones del tránsito intestinal** (diarrea, constipación o ambos), en ausencia de una causa orgánica demostrable.

Se considera un **trastorno de la interacción intestino-cerebro**, donde confluyen alteraciones en la motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, disbiosis intestinal y factores psicosociales.

El SII es **altamente prevalente**: afecta entre el **10% y 20% de la población mundial**, con predominio en mujeres jóvenes y de mediana edad. En Chile, los estudios de la SChGE estiman una prevalencia cercana al **16%**, siendo una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria y gastroenterología.

Aunque **no compromete la sobrevida**, el SII tiene un impacto significativo en la **calidad de vida, ausentismo laboral y uso de recursos de salud**.

En el **EUNACOM**, es un tema recurrente por su alta prevalencia y por la necesidad de diferenciarlo de patologías orgánicas graves como cáncer colorrectal, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El SII no tiene una causa única; es una **entidad multifactorial** donde intervienen factores biológicos, psicológicos y ambientales.

2.1. Hipersensibilidad visceral

Los pacientes con SII presentan una **percepción exagerada del dolor intestinal**, aun ante estímulos fisiológicos normales (distensión, gas, alimentos).

Se atribuye a alteraciones en la señalización de las fibras aferentes viscerales y una **modulación defectuosa del dolor** en el sistema nervioso central.

2.2. Trastornos de motilidad intestinal

Existe una **alteración en la coordinación neuromuscular del tubo digestivo**, con tránsito acelerado (SII con diarrea) o enlentecido (SII con constipación).

2.3. Disbiosis intestinal

Estudios recientes muestran cambios en la microbiota intestinal, con menor diversidad bacteriana y aumento de especies productoras de gas y metano.

En algunos casos, el SII aparece luego de una **gastroenteritis infecciosa**, lo que se denomina **SII postinfeccioso**.

2.4. Factores psicosociales

El **estrés, ansiedad y depresión** modulan la actividad del eje intestino-cerebro, exacerbando los síntomas.

La retroalimentación entre sistema nervioso autónomo y microbiota explica la cronicidad del cuadro.

2.5. Factores dietarios

El consumo de alimentos ricos en **FODMAPs** (carbohidratos fermentables como fructosa, lactosa, sorbitol y oligosacáridos) puede inducir síntomas por distensión y fermentación colónica.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones principales

El diagnóstico se basa en síntomas característicos, definidos por los **criterios de Roma IV (2016)**:

Dolor abdominal recurrente, al menos 1 día por semana en los últimos 3 meses, asociado a 2 o más de los siguientes:

- Relación con la defecación (mejora o empeora).
- Cambio en la frecuencia de las deposiciones.
- Cambio en la forma (consistencia) de las heces.

Los síntomas deben haber comenzado al menos **6 meses antes del diagnóstico**.

3.2. Subtipos clínicos según patrón de tránsito

- **SII con predominio de diarrea (SII-D)**: heces blandas o acuosas en >25% de las deposiciones.

- **SII con predominio de constipación (SII-C):** heces duras o fragmentadas en >25% de las deposiciones.
- **SII mixto (SII-M):** alternancia entre diarrea y constipación.
- **SII no clasificable:** sin patrón claro.

3.3. Síntomas acompañantes

- Distensión o meteorismo.
- Sensación de evacuación incompleta.
- Mucosidad rectal sin sangre.
- Fatiga, insomnio, ansiedad o depresión asociadas.

3.4. Signos de alarma (“red flags”)

Deben hacer sospechar enfermedad orgánica subyacente y motivar estudio complementario:

- Sangre oculta o visible en deposiciones.
- Fiebre o anemia.
- Pérdida de peso involuntaria.
- Diarrea nocturna o esteatorrea.
- Inicio de síntomas después de los 50 años.
- Antecedentes familiares de cáncer colorrectal o enfermedad inflamatoria intestinal.

En presencia de estos signos, **no debe diagnosticarse SII sin estudios adicionales.**

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El SII es un **diagnóstico clínico de exclusión razonable**, donde los exámenes se orientan a descartar patología orgánica.

4.1. Laboratorio básico

- **Hemograma completo:** descartar anemia o inflamación.
- **PCR y VSG:** deben ser normales (descarta EI).
- **TSH:** en constipación persistente, para descartar hipotiroidismo.
- **Glicemia y electrolitos:** en diarreas crónicas o deshidratación.
- **Serología celíaca (anticuerpos anti-transglutaminasa IgA):** útil en diarrea crónica.

4.2. Exámenes de imágenes y endoscopia

- **Colonoscopia:** indicada solo si hay signos de alarma, edad >50 años o historia familiar de cáncer colorrectal.
- **Ecografía abdominal:** puede descartarse patología biliar o pélvica.

4.3. Diagnóstico positivo

Se realiza cuando el paciente cumple los **criterios de Roma IV** y se descartan causas estructurales, metabólicas o infecciosas.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL y ACG 2021)

El tratamiento es **individualizado**, combinando **medidas dietéticas, farmacológicas y psicológicas**.

No existe un fármaco curativo; el objetivo es **mejorar la calidad de vida y controlar los síntomas**.

5.1. Educación y abordaje general

1. Explicar el diagnóstico:

Reafirmar al paciente que se trata de un trastorno funcional, benigno y crónico, pero que **no progresa a cáncer ni enfermedad orgánica**.

2. Identificar factores gatillantes: estrés, ansiedad, alimentos, fármacos.

3. **Terapia de apoyo psicológico:** técnicas cognitivo-conductuales, relajación o mindfulness, demostraron efectividad.
 4. **Ejercicio físico regular:** alivia síntomas y mejora el bienestar general.
-

5.2. Tratamiento dietético

- **Dieta baja en FODMAPs:** reducir consumo de legumbres, manzanas, cebolla, lácteos, edulcorantes artificiales y alimentos ultraprocesados.
- **Aumentar fibra soluble (psyllium):** útil en SII con constipación, evitando fibra insoluble (salvado de trigo).
- **Evitar cafeína, alcohol y comidas copiosas.**
- **Regular horarios de comidas.**
- En pacientes con SII-D, limitar lactosa y grasas.

El acompañamiento de un **nutricionista entrenado en SII** mejora la adherencia y resultados.

5.3. Tratamiento farmacológico (según subtipo)

A. SII con predominio de diarrea (SII-D)

- **Loperamida:** 2–4 mg después de cada deposición líquida, máximo 16 mg/día.
Mejora la frecuencia y urgencia, pero no el dolor.
- **Rifaximina:** antibiótico no absorbible (550 mg cada 8 h por 14 días), útil en SII-D refractario o postinfeccioso.
- **Colestiramina:** útil si hay componente de malabsorción biliar.
- **Antiespasmódicos:** mebeverina o butilioscina para dolor abdominal.
- **Antidepresivos tricíclicos (amitriptilina 10–25 mg nocturno):** modulan dolor visceral y motilidad.

B. SII con predominio de constipación (SII-C)

- **Fibras solubles (psyllium):** primera línea.
- **Laxantes osmóticos:** polietilenglicol o lactulosa, evitando uso prolongado de estimulantes.
- **Lubiprostona o linaclotida:** si no responde a medidas previas.
- **ISRS (fluoxetina, sertralina):** mejoran síntomas y estado anímico.

C. SII mixto (SII-M)

- Ajustar tratamiento según predominio de síntomas.
 - En casos refractarios, considerar terapia psicológica intensiva o manejo multidisciplinario.
-

5.4. Tratamiento del dolor y distensión

- **Antiespasmódicos (butilioscina, pinaverio, mebeverina):** reducen espasmos intestinales.
 - **Probióticos:** cepas como *Bifidobacterium infantis* o *Lactobacillus plantarum* pueden reducir meteorismo y distensión.
 - **Antidepresivos a bajas dosis:** regulan percepción visceral.
-

5.5. Manejo psicológico

El **eje intestino-cerebro** es fundamental en el SII; por ello, el manejo debe incluir:

- Terapia cognitivo-conductual.
- Hipnoterapia dirigida al intestino (evidencia ACG 2021).
- Técnicas de reducción de estrés (mindfulness, yoga, respiración diafragmática).

Estos abordajes son especialmente útiles en pacientes con **ansiedad o depresión coexistente**.

6. Complicaciones

El SII **no produce complicaciones orgánicas** como úlceras, sangrado o cáncer.

Sin embargo, las principales consecuencias clínicas son **psicológicas y funcionales**:

- **Discapacidad social y laboral** por síntomas persistentes.
 - **Trastornos del sueño y fatiga crónica.**
 - **Trastornos ansiosos o depresivos secundarios.**
 - **Polimedicación innecesaria o exámenes excesivos** cuando no se reconoce su naturaleza funcional.
-

7. Pronóstico

- El SII es **crónico pero benigno**.
 - La mayoría de los pacientes logra controlar los síntomas con educación, dieta y manejo médico.
 - En 50–70% de los casos, los síntomas fluctúan o mejoran con el tiempo.
 - El pronóstico empeora si existe **ansiedad, depresión o bajo apoyo social**.
-

8. Prevención y seguimiento

1. **Identificar precozmente** el patrón funcional y evitar estudios invasivos innecesarios.
2. **Educar** al paciente sobre la benignidad del cuadro.
3. **Promover hábitos saludables:** ejercicio, sueño regular, hidratación, alimentación equilibrada.
4. **Control nutricional periódico** en dietas restrictivas.
5. **Acompañamiento psicológico** si hay síntomas ansiosos o depresivos.

6. Reevaluar si aparecen **signos de alarma** (sangrado, pérdida de peso, fiebre, anemia).
-

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. El **SII** es un **diagnóstico clínico**, basado en los **criterios de Roma IV**.
2. No se asocia a daño estructural ni aumenta el riesgo de cáncer colorrectal.
3. El dolor abdominal mejora tras la defecación y se asocia a cambios en frecuencia o consistencia de las heces.
4. En **SII-D**, rifaximina y loperamida son útiles; en **SII-C**, fibra soluble y laxantes osmóticos.
5. La **dieta baja en FODMAPs** es una intervención efectiva.
6. Los **antidepresivos a bajas dosis** modulan la percepción visceral.
7. En EUNACOM, suelen preguntar por **diagnóstico diferencial y manejo inicial**.

Errores comunes:

- Indicar colonoscopia de rutina en todos los pacientes.
 - Usar antibióticos o corticoides sin indicación.
 - Omitir evaluación de signos de alarma.
 - No abordar el componente psicológico.
 - Confundir SII con enfermedad celíaca o EII sin pruebas confirmatorias.
-

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **SII** es un trastorno funcional caracterizado por **dolor abdominal y alteraciones del tránsito intestinal**, sin causa orgánica.

2. El diagnóstico se basa en los **criterios de Roma IV** y la ausencia de signos de alarma.
3. La **educación y dieta baja en FODMAPs** son pilares del manejo.
4. Los **tratamientos farmacológicos** se individualizan según el subtipo (diarrea o constipación).
5. El **estrés y la ansiedad** juegan un rol clave en la fisiopatología y manejo.
6. Es una enfermedad **benigna, no evolutiva ni maligna**.
7. En EUNACOM, las preguntas suelen centrarse en el diagnóstico diferencial y el manejo integral.